

PLATAFORMA DE ORQUESTRAÇÃO CLÍNICA • HOSPITAIS & OPERADORAS VERTICALIZADAS

Doutor-AI: o *novo modelo operacional* da saúde.

O QUE É

Copiloto clínico + orquestração de protocolos

PARA QUEM

Hospitais e operadoras verticalizadas

EM PRODUÇÃO

22 unidades • 1.842 médicos

STATUS

Confidencial • v1

SUMÁRIO EXECUTIVO

Não é IA. É a nova forma *de operar em saúde.*

A Doutor-AI é a camada que *orquestra e garante a execução* da decisão dentro do fluxo assistencial — pronto-socorro, ambulatório, internação e enfermagem.

Para hospitais e operadoras verticalizadas, isso significa *menos variabilidade clínica, mais aderência a protocolo e eficiência operacional* mensurável.

550K₊

atendimentos processados pela plataforma em produção.

22

unidades ativas · 77 em implantação · 1.842 médicos.

98%

assertividade clínica auditada em coorte de 12 instituições.

+65%

aderência a protocolos clínicos institucionais pós-implantação.

A TESE

Conhecimento, a saúde tem. Falta *tecnologia que executa*.

O conhecimento existe, a evidência existe e já há *múltiplos sistemas* — prontuário, protocolos, BI. O que falta é a camada que *orquestra e sustenta a execução* no fluxo: um copiloto que sugere a melhor conduta no momento certo, sob pressão de tempo e rodízio de equipe.

A OPERAÇÃO DE SAÚDE HOJE

Depende da **memória** e do **plantão** de cada profissional.

- **Variabilidade clínica** · mesma queixa, condutas diferentes
- **Protocolo no PDF** · existe, mas não chega à beira do leito
- **Documentação manual** · retrabalho, glosa e tempo perdido
- **Auditoria retrospectiva** · o erro só aparece depois
- **Sem telemetria** · gestão não enxerga a aderência real



A OPERAÇÃO *COM DOUTOR-AI*

A boa medicina vira *execução garantida* e mensurável.

- **Orquestração** · o agente certo atua em cada estágio do fluxo
- **Protocolo no contexto** · sugestão na hora da decisão
- **Documentação automática** · prontuário, codificação e alta sem retrabalho
- **Alerta & monitoramento** · red/yellow flags antes do erro
- **Aderência em tempo real** · eficiência e qualidade auditáveis

A SOLUÇÃO • ARQUITETURA DE EXECUÇÃO

A camada que *opera o fluxo* do hospital inteiro.

Tudo o que o hospital precisa para orquestrar a operação em um só lugar — uma arquitetura de execução que roda *em paralelo* ao trabalho de médicos e enfermeiros, do atendimento à governança.

01 • COPILOTO

Copiloto Assistencial

Transcrição clínica, preenchimento automático do prontuário e dos documentos, sugestão de CID e alertas clínicos durante o atendimento.

02 • PROTOCOLOS

Pertinência baseada em protocolos

Protocolos institucionais versionados, com fonte e referência. A evidência certa, no momento certo da decisão.

03 • QUALIDADE

Padrão de qualidade para tomada de decisão

Aderência médica × protocolo, pertinência de exames e condutas, top gaps por especialidade e drill-down por médico.

04 • GOVERNANÇA

Governança dos dados em tempo real

Dashboards de governança, produção, erros clínicos e impacto financeiro — visão executiva auditável.

Transcreve a consulta e *monta o prontuário* sozinho.

A escuta ambient captura a conversa e devolve um prontuário estruturado — anamnese, exame físico, hipóteses e CID — sem o médico digitar. O tempo de tela vira tempo de paciente.

–70% do tempo gasto em documentação clínica.

50% de redução no burnout médico — 50% do burnout decorre do preenchimento de documentação clínica. Menos tela, mais olho no paciente.

30–40% de redução no tempo de consulta — menos burocracia, mais atendimentos no dia.

COMO FUNCIONA

01 Escuta ambient

Captura a consulta em áudio, sem formulário.

02 Estrutura clínica

Anamnese, exame, hipóteses e CID organizados automaticamente.

03 Revisão em 1 clique

O médico valida e assina — o registro nasce completo e auditável.

04 Alertas clínicos em tempo real

Red/yellow flags de sepse, deterioração, interações medicamentosas e contraindicações — gerados durante a consulta, não em background.

Garante a *pertinência* antes de decidir.

Antes de sugerir qualquer conduta, a plataforma **entende o contexto e traz a evidência** — garantindo a pertinência de exames, internações e condutas frente ao quadro e ao protocolo. Menos desperdício, glosa e exposição do paciente, sem travar a autonomia médica.

-51 % de glosas em unidades com pertinência ativa.

COMO FUNCIONA

01 Entende o contexto

Quadro clínico, histórico, exames e protocolo aplicável.

02 Traz a evidência

Cruza solicitação com indicação clínica e diretriz.

03 Garante a pertinência

Sinaliza desvio antes do faturamento • justificativa auditável • menos retrabalho.

PROPOSTA DE VALOR • 03 DE 04

Com pertinência garantida, sugere a *conduta certa*.

O diferencial não é ter evidência — é **ranquear e contextualizar** qual a melhor evidência para aquele caso específico. A plataforma pondera diretriz, protocolo institucional e fatores regionais para sugerir a conduta certa e preencher a documentação, com fonte e versão.

+65 % de aderência ao protocolo institucional.

NA INTERNAÇÃO

Doutor-AI faz um screening contínuo do paciente: red e yellow flags, interações e contraindicações, pontos de inflexão e sinais de deterioração ou melhora.

COMO FUNCIONA

01 Lê o contexto completo

Queixa, histórico, biomarcadores, comorbidades e perfil regional.

02 Ranqueia a evidência

Prioriza a melhor evidência para aquele caso — diretriz, protocolo e contexto.

03 Sugere e documenta

Conduta personalizada + documentação preenchida automaticamente.

04 Médico decide

A IA sugere; o médico prescreve. Sempre.

05 Auditoria clínica

Taxas de aderência a protocolo e de glosa por médico, com drill-down operacional — governança do dado e da operação.

PROPOSTA DE VALOR • 04 DE 04

A *governança* do dado clínico e operacional em tempo real.

Cada atendimento gera dados estruturados e auditáveis — a plataforma consolida aderência, qualidade do prontuário, pertinência e impacto financeiro em tempo real, entregando visibilidade executiva completa para gestores e equipes assistenciais.

100 de sugestões auditadas e registradas •
% conformidade SBIS-CFM 2.

COMO FUNCIONA

01 Telemetria em tempo real

Aderência, qualidade do prontuário e pertinência mensuradas a cada atendimento.

02 Dashboards executivos

Produção, erros clínicos, glosas e ROI assistencial em painel único e exportável.

03 Drill-down até o médico

De rede até consulta-paciente — rastreabilidade total com framework de compliance.

04 Auditoria por IA secundária

Cada sugestão auditada e registrada com changelog • conformidade SBIS-CFM 2.

UMA PLATAFORMA · TODAS AS SOLUÇÕES PARA OS SEUS FLUXOS

O mesmo motor atua em *cada contexto* assistencial.

Pronto-socorro, internação, ambulatório e cirurgia — o mesmo motor de protocolos e auditoria, com visões prontas para os perfis de médico e de enfermagem.

FLUXO 01

Pronto-Socorro

Triagem → consulta → exames → reavaliação → desfecho, com pertinência e tempo de permanência sob controle.

● EM RELEASE

FLUXO 02

Internação

Admissão → evolução → coordenação de cuidado → alta, com documentação e códigos de resposta.

● EM RELEASE

FLUXO 03

Ambulatório / Telemedicina

Consulta com escuta ambient, protocolo no fluxo e aderência mensurada por especialidade.

● EM RELEASE

FLUXO 04

Cirurgia

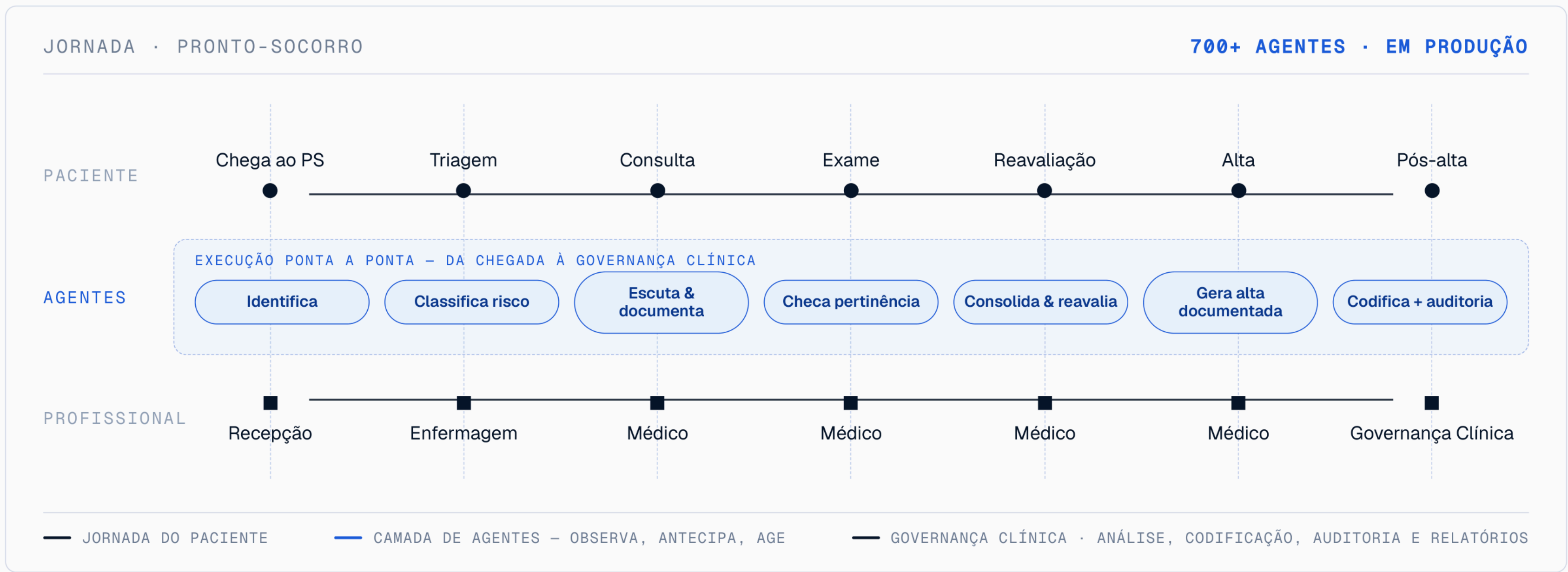
Jornada cirúrgica — pré, intra e pós-operatório com protocolos e checklist de segurança.

○ EM DESENVOLVIMENTO

DOIS PERFIS, PRONTOS Cada fluxo tem visões dedicadas para o **perfil do médico** e o **perfil da enfermagem** — ambos em produção.

Uma segunda camada de IA *em todo o fluxo*.

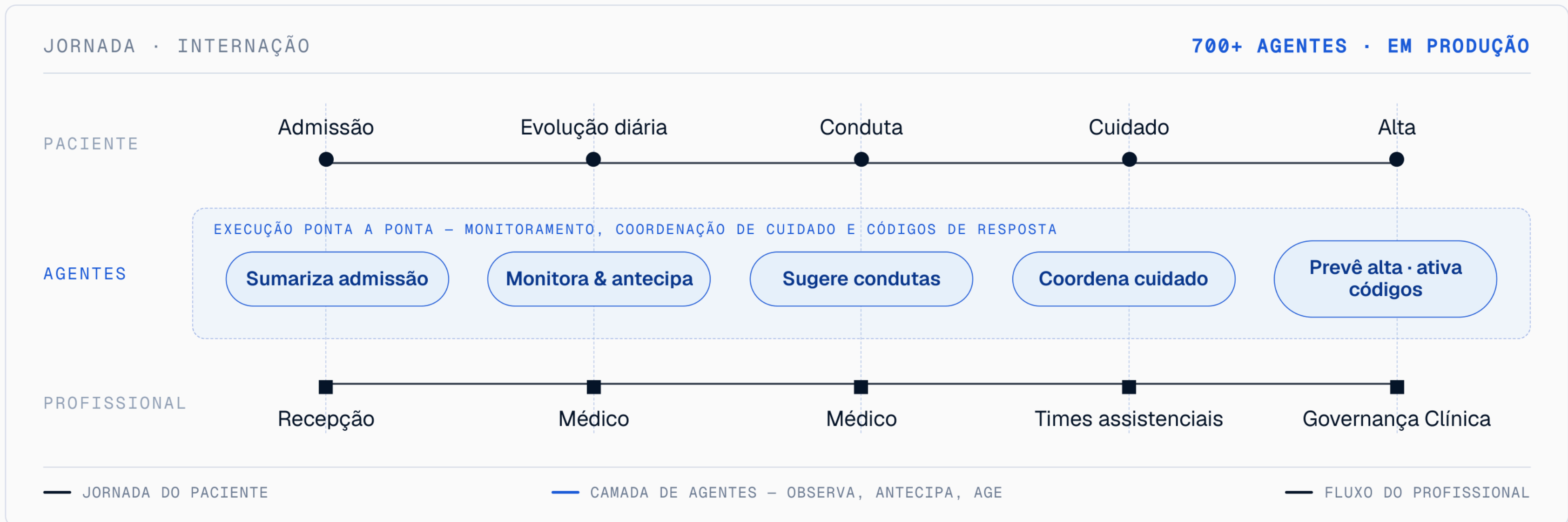
Múltiplos agentes observam, antecipam e agem em cada etapa — da chegada à governança clínica, sem tirar a decisão do médico.



FLUXO · INTERNAÇÃO

A mesma camada de IA, agora *na internação*.

Da admissão à alta, os agentes monitoram a evolução, antecipam deterioração, sugerem condutas e coordenam o cuidado multissetorial — gerando tarefas para os times e ativando códigos de resposta quando preciso.



E também no *ambulatório*, da consulta ao retorno.

O mesmo motor de protocolos e auditoria acompanha a consulta eletiva — contexto, conduta e aderência mensurados por especialidade.



SLIDE PENDENTE

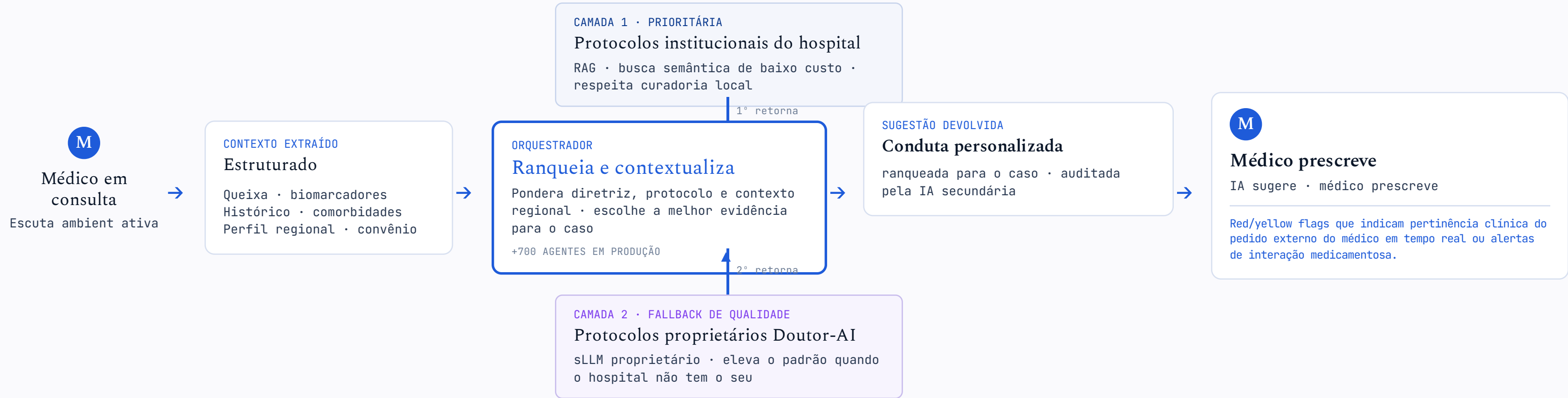
Envie a imagem para
inserção nesta posição.

SLIDE PENDENTE

Envie a imagem para
inserção nesta posição.

ARQUITETURA • COMO A RECOMENDAÇÃO NASCE

A *melhor evidência* para aquele caso específico.



O copiloto que *escuta*, estrutura e documenta.

doutor-ai.com

OPERAÇÕES

Agenda

Check-in

Recepção

Consulta

Checkout

Pacientes

Navegação

Codificação

Auditoria Op.

Faturamento

Discussões

ANALYTICS

Visão Executiva

Governança Clínica

Análise Clínica

Pertinência

Erros Clínicos

Engajamento

Produção

Análise Financeira

Relatórios

Atendimento em curso

REC · 12:47

MARIA SILVA #PT-2847

68 anos · Feminino · Cardiologia · Retorno

Resumo Clínico (IA): Paciente com diagnóstico prévio de IC sistólica, em acompanhamento ambulatorial. FEVE atual de 42% (Eco recente). Apresenta dispneia aos médios esforços, edema (+/4+) bilateral e crepitações em bases pulmonares. Em uso de IECA, beta-bloqueador e diurético de alça. Necessária otimização da terapia.

Atendimento Atual 5 Histórico Exame Físico

QUEIXA PRINCIPAL

Dispneia aos médios esforços · evolução de ~3 semanas, com piora progressiva.

DIAGNÓSTICOS · CID-10

I50.2 · IC sistólica J81 · Congestão pulmonar

SINAIS VITAIS

FC 78 bpm

PA 148x92 mmHg

FR 22 rpm

SPO2 96 %

TEMP 36,4 °C

EXAME FÍSICO

Edema (+/4+) bilateral Crepitações em bases Eupneica em repouso

Documentação preenchida automaticamente pela IA · em sincronia com o áudio da consulta

Buscar paciente, consulta, médico...

Documentação

Finalizar consulta

DR

COPILOTO CLÍNICO · TEMPO REAL

IA ativa

Conversa estruturada

ALERTAS DA IA · 2

RED FLAG · SEGURANÇA

Risco de hipercalemia

IECA + espironolactona com função renal limítrofe · checar K+ e creatinina antes de otimizar a terapia.

YELLOW FLAG · ATENÇÃO

PA não controlada · 148x92 mmHg

Acima da meta para IC sistólica · avaliar ajuste anti-hipertensivo antes da alta.

DR. R. ALMEIDA · DITADO CLÍNICO

Paciente trouxe Eco com FEVE de 42%. Queixando dispneia aos médios esforços. Apresentando edema (+/4+), crepitações em bases bilaterais, eupneica, SatO2 96%.

ACHADOS ESTRUTURADOS

Identifiquei evolução de IC com piora funcional (NYHA II → III), congestão pulmonar bilateral e edema periférico moderado. FEVE de 42% confirma disfunção sistólica moderada.

Como classificar a pressão arterial atual?

Normal (até 120/80) Limítrofe (120-140 / 80-90) Elevada (>140/90) ✓

RECOMENDAÇÃO

Sugiro otimização do diurético de alça, ajuste do IECA e Eco de controle em 30 dias. Protocolo IC institucional · v3.2 aplicado.

PROTOCOLO APLICADO

IC Sistólica · v3.2 · Cardiologia institucional

5 condutas sugeridas · revisão no checkout

ESCUTA AMBIENT

A consulta é capturada em áudio · IA transcreve, estrutura e gera o resumo clínico.

CONVERSA GUIADA

Chips e perguntas refinam o raciocínio clínico sem tirar o médico do fluxo.

PROTOCOLO APLICADO

Cada decisão se conecta ao protocolo institucional · pronto pro checkout.

A IA *sugere*. O médico decide.

doutor-ai.com

OPERAÇÕES

Agenda

Check-in

Recepção

Consulta

Checkout

Pacientes

Navegação

Codificação

Auditoria Op.

Faturamento

Discussões

ANALYTICS

Visão Executiva

Governança Clínica

Análise Clínica

Pertinência

Erros Clínicos

Engajamento

Produção

Análise Financeira

Relatórios

Check-Out Médico

Em encerramento

TESTE 03

56 anos

Masculino

TESTE 03

Paciente masculino, 48 anos, com histórico de Infarto Agudo do Miocárdio, Cardiomiopatia isquêmica, Insuficiência Cardíaca Crônica Sistólica, Insuficiência Cardíaca Congestiva e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Em [20/06/2024], apresentou piora da Insuficiência Cardíaca Crônica com fração de ejeção de 50% e hipocalemia, esta última resolvida em [25/06/2024] com suspensão da Furosemida. Em [DATA DA CONSULTA ANTERIOR], a Furosemida foi reintroduzida. Atualmente, faz uso contínuo de AAS, Atorvastatina, Carvedilol (3,125 mg, 2 vezes ao dia), Espironolactona (25 mg, 1 vez ao dia).

Contexto Clínico

Atendimento Atual

Itens do Checkout 5

EXAMES 4

LABORATORIAIS 3

IMAGEM 1

ENCAMINHAMENTOS 1

Exames Laboratoriais

1. Hemograma Completo

2. Eletrólitos (Sódio, Potássio, Cloro)

3. Ureia e Creatinina

Ultrassonografia Doppler do Membro Inferior

1. Ultrassonografia Doppler do Membro Inferior

Consulta com Cirurgião Vascular

Prontuário Inteligente

Discussão Clínica

Buscar paciente, consulta, médico...

Voltar à Consulta

Dados do Encerramento

DR

SUGESTÕES DA IA

5 aceitas

6 sugestões de conduta

ALERTAS IA DO CHECKOUT (2)

INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA

Possível interação: Dipirona x AAS

Paciente faz uso contínuo de AAS. Dipirona pode aumentar risco de sangramento e hemorragia gástrica em uso prolongado. Considerar alternativa.

FORA DE PERTINÊNCIA

Item criado pelo médico fora de pertinência

A prescrição de Dipirona não tem evidência clínica direta no protocolo aplicado. Justifique para incluir no checkout.

EXAME

Ultrassonografia Doppler do Membro Inferior

IA

Aceito

EXAME

Hemograma Completo

IA

Aceito

EXAME

Eletrólitos (Sódio, Potássio, Cloro)

IA

Aceito

EXAME

Ureia e Creatinina

IA

Aceito

RECEITA

Dipirona 500mg

Médico

Pendente

FORA DE PERTINÊNCIA · MÉDICO CRIOU VIA CHAT

IA não encontrou evidência no protocolo aplicado. Aguardando justificativa do médico.

ENCAMINHAMENTO

Consulta com Cirurgião Vascular

IA

Aceito

6 SUGESTÕES

A IA propõe condutas durante o atendimento — exames, encaminhamentos, receitas.

ALERTAS IA

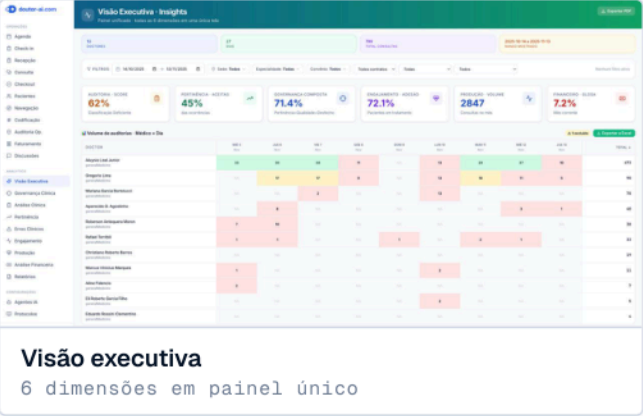
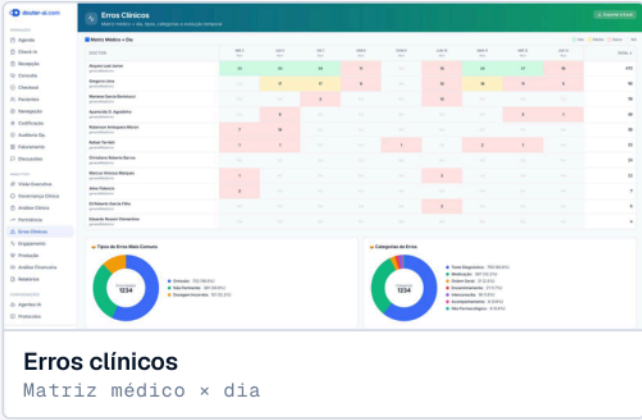
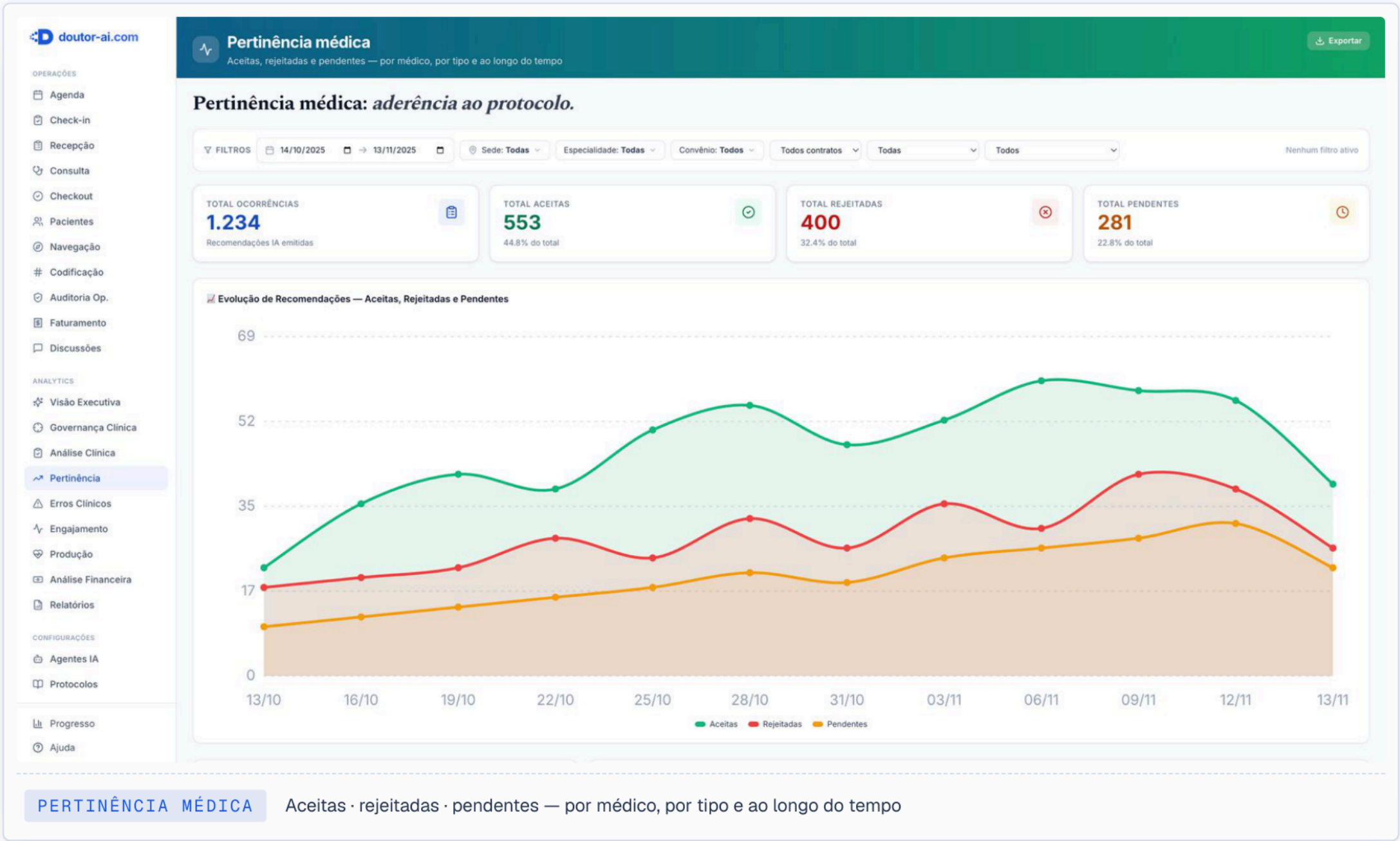
Interação medicamentosa e fora de pertinência sinalizados antes da assinatura.

DECISÃO REGISTRADA

Aceitar · pendente · rejeitar — toda escolha do médico é auditável.

PLATAFORMA • SUITE DE RELATÓRIOS EM PRODUÇÃO

A camada de *governança clínica* de toda a operação assistencial.



EM PRODUÇÃO

Mais de 10 relatórios já rodando para clientes-âncora · todos exportáveis.

VIEW NOVARTIS

Recorte dedicado por protocolo validado · dados agregados e anonimizados.

DRILL-DOWN

De agregado-rede até consulta-paciente, respeitando o framework de compliance.

Métricas de produção · ao vivo

UM NEGÓCIO EM PRODUÇÃO – RECEITA RECORRENTE REAL, NÃO PILOTO.

● AO VIVO

Todas as instituições ▾

Últimos 12 meses ▾

ATENDIMENTOS

↑ +38% QoQ

550K+

MÉDICOS ATIVOS

↑ +41% QoQ

1.842+

Especialistas em consultas reais por dia

UNIDADES ATIVAS

↑ +8 novas

22

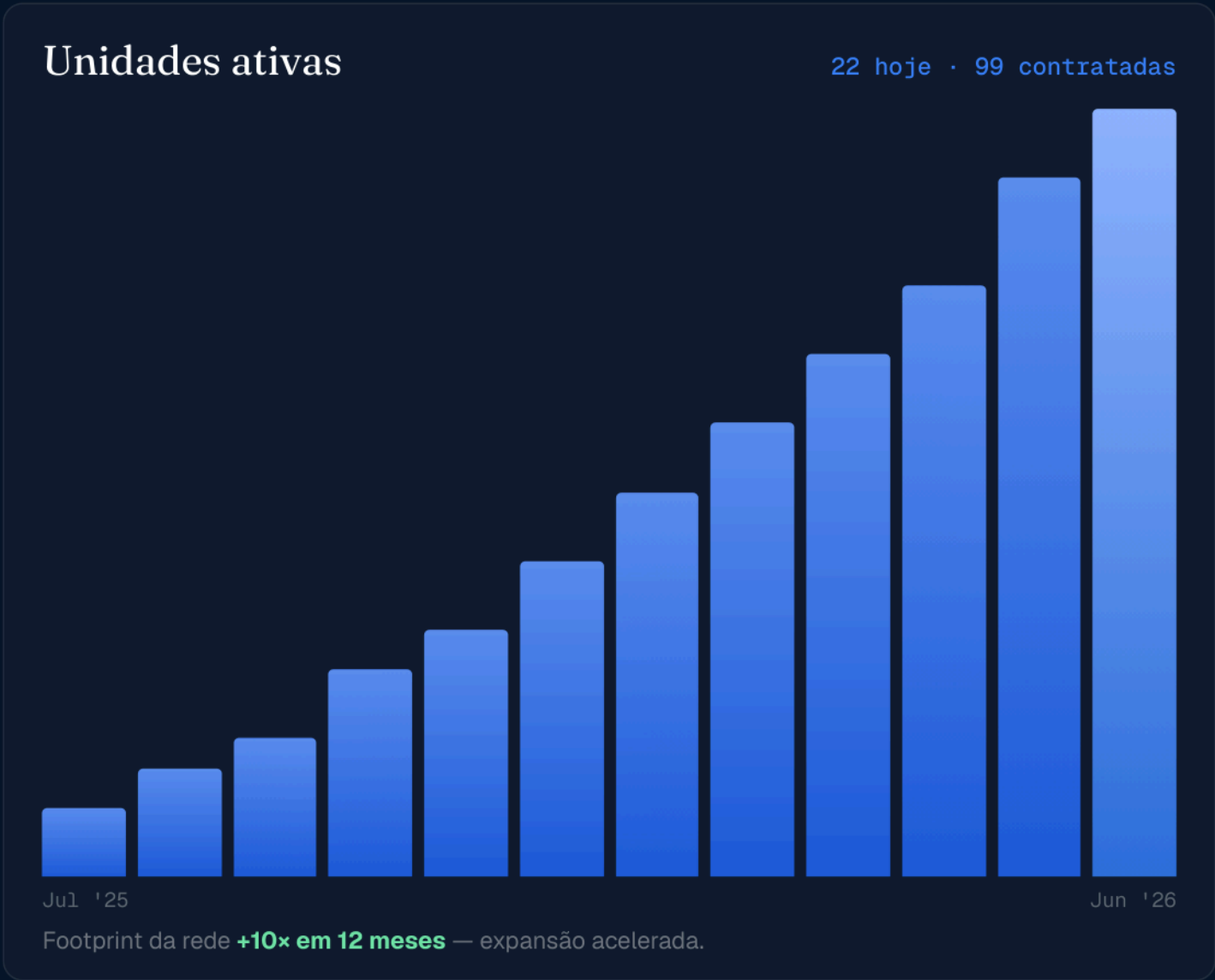
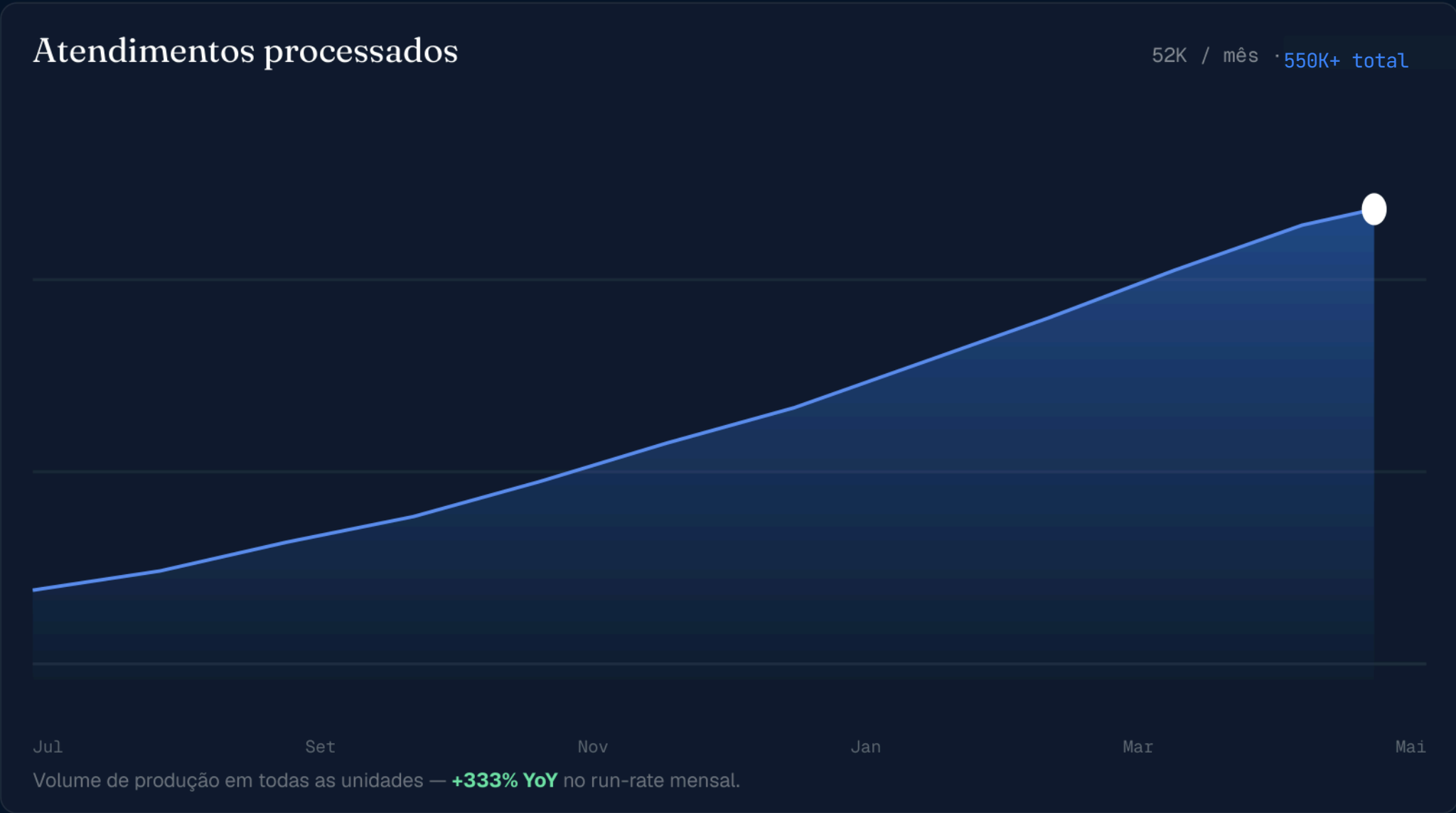
Hospitais, clínicas e telemedicina ativos

ADERÊNCIA MÉDIA

↑ +12 pp

87%

a protocolos institucionais auditados



98,7%

ACURÁCIA DA IA

em produção, fluxos clínicos reais

95%

ADOÇÃO · 30 DIAS

médicos ativos após 30 dias

81

NPS MÉDICO

satisfação classe mundial (>70)

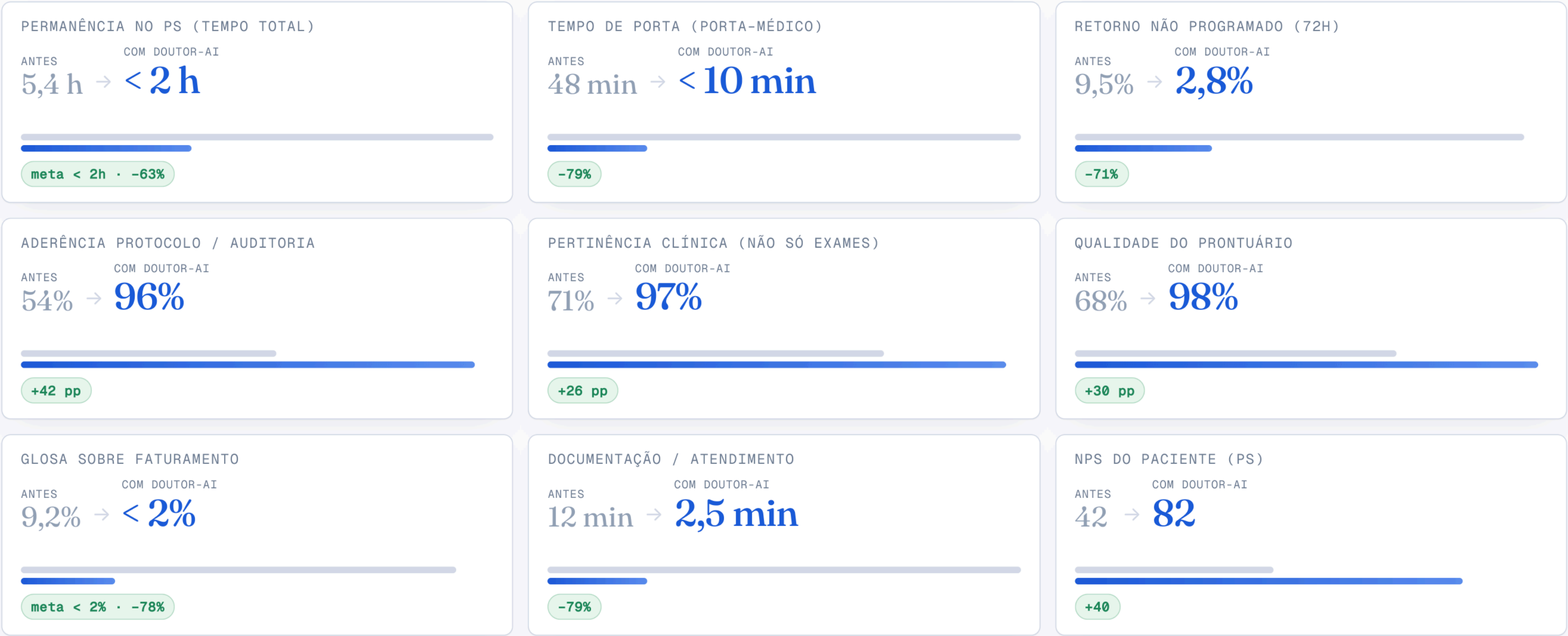
77+

EM ONBOARDING

22 ativos · 77+ contratados em rampa nos próximos 12 meses

O que muda no painel do *gestor hospitalar*.

O mesmo indicador, antes e com Doutor-AI — metas auditadas em nível de *benchmark global* de qualidade e eficiência.



MODELO DE NEGÓCIO · COMO FUNCIONA

SaaS clínico, cobrado *por atendimento*.

Primeiro o setup de implantação; depois, utilização variável — você paga pelo que usa, por atendimento. Modular: ative só o que precisa ou o pacote completo, a Medicina Inteligente.

COMO FUNCIONA

01

Setup & implantação

Integração ao prontuário e curadoria · personalizações a R\$ 250/hora

.

02

Cobrança por atendimento

Utilização variável e recorrente — você paga pelo que usa.

03

Modular

Transcrição, protocolos, auditoria e governança — avulsos ou no pacote completo.

ITEM	O QUE INCLUI	COBRANÇA
Transcrição & prontuário	Escuta ambient, prontuário e documentos automáticos, CID e red flags	<i>a partir de R\$ 2,00</i> / atendimento · mês
+ Protocolos	Central editorial versionada + sugestão contextual no fluxo	<i>+ R\$ 0,35</i> / atendimento · mês
+ Auditoria & pertinência	Aderência em tempo real, pertinência de condutas, drill-down	<i>+ R\$ 0,25</i> / atendimento · mês
+ Governança & analytics	Dashboards executivos, produção, erros clínicos e financeiro	<i>+ R\$ 0,10</i> / atendimento · mês
Medicina Inteligente COMPLETO	Copiloto + Protocolos + Auditoria + Governança, tudo integrado	<i>R\$ 2,70</i> / atendimento · mês
Valores de referência · tabela detalhada e desconto por volume na proposta comercial.		

Quanto a operação *economiza* por mês.

Simulação para um pronto-socorro de porte médio — os ganhos potenciais mais rápidos de mensurar, sem revelar faturamento.

OPERAÇÃO MÉDIA · PREMISSAS

Consultas de pronto-socorro 4.000 / mês

Modelo de cobrança por atendimento

CUSTO DOUTOR-AI · MEDICINA INTELIGENTE

R\$ 10,8 mil / mês

4.000 atendimentos × R\$ 2,70

GANHOS MENSAIS ESTIMADOS

Redução de glosa · 3–5 p.p. do faturamento R\$ 23–38 mil

Enfermagem de DRG & benchmarking absorvida R\$ 30.000

Redução do time de auditoria · processos mais redondos R\$ 18.000

Ganho total estimado R\$ 71–86 mil / mês

CUSTO R\$ 10,8 mil

GANHO ≈ R\$ 78 mil

GANHO LÍQUIDO

~R\$ 68 mil/mês

ROI

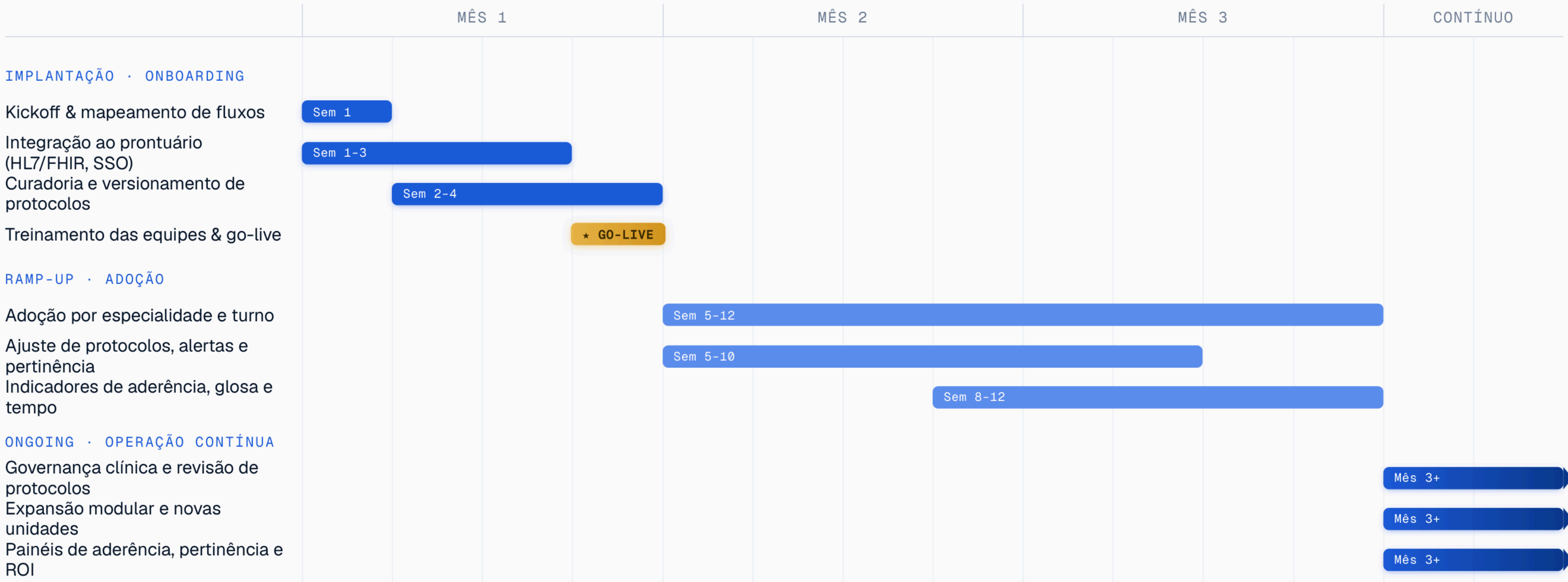
~7×

Payback imediato · valores
indicativos, ajustados na
proposta

CRONOGRAMA · IMPLANTAÇÃO, RAMP-UP E ONGOING

Três fases, do *go-live* à operação contínua.

O processo segue a jornada de implantação da Doutor-AI — do setup ao ongoing, com atividades e responsáveis acompanhados em cada frente.





Inteligência que cuida

ANDRÉ CHADE

Diretor Comercial & Time Médico

EMAIL

andre.chade@doutor-ai.com

SITE

doutor-ai.com